

# PDF ANONIMIZADO

ID publico: case\_0301

Paginas del documento: 16

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

---

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

nas o atributo longitudinalidade mostrou resultado favorável com 80,7% os demais parâmetros como abordagem centrada no território, acesso e egralidade e coordenação do cuidado, não atingiram os resultados desejados. Observou-se a necessidade de incentivar a prática dos atributos da Política Nacional da Atenção Básica pelos profissionais das equipes da ESF e usuários, pois muitos dos parâmetros comuns às equipes não estão sendo realizados nos territórios rurais.

**Palavras-chave:** Atenção Primária à Saúde. Estratégias de Saúde Nacionais. Serviços de Saúde Rural.

presentó debilidades. Solo el atributo longitudinalidad presentó un resultado 80,7% de las respuestas y los demás parámetros no alcanzaron los resultados

**conclusión:** Se observó la necesidad de incentivar la práctica de los atributos de Atención Primaria por los profesionales de los equipos de la ESF y los usuarios, ya que muchos de los parámetros comunes a los equipos no se están realizando en las zonas rurales.

**Palabras clave:** Atención Primaria de Salud. Estrategias de Salud Nacionales. Servicios de Salud Rurales.

## INTRODUÇÃO

No Brasil, adota-se a Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo de atenção à saúde. O modelo prioriza a análise da situação de saúde baseando-se no território adstrito e suas peculiaridades, considerando os princípios da equidade e da universalidade para avaliar determinantes de vulnerabilidade e perfil da população (Brasil, 2017).

A ESF tem a intenção de reorientar o modelo de atenção à saúde, por meio da identificação de um conjunto de questões relativas às bases conceituais e operacionais do que se concebe como “Atenção Básica à Saúde” no Brasil (e de forma ampla, Atenção Primária à Saúde – APS), e de suas relações com os demais níveis do sistema e as interfaces com as Redes de Atenção à Saúde – RAS (Arruda, 2019).

Cabe lembrar que a APS está diretamente relacionada aos cuidados das Populações do Campo, da Floresta e das águas (PCFA). Deve estar preparada para lidar com as singularidades do processo de adoecimento desse grupo e as especificidades nos aspectos biopsicossociais envolvidos no intuito de realizar a integralidade da atenção de maneira adequada e eficaz (Gerhardt; Lopes, 2015; Lima *et al.*, 2018).

Há limitações que necessitam de superação para a consolidação de uma APS de qualidade, como observa-se nos territórios das PCFA, seja pela dificuldade de acesso, carência de serviços de saúde, falta de materiais para assistência, escassez e dificuldade de fixação de profissionais, seja pelas barreiras políticas. Garantir o acesso à saúde, a integralidade e a resolubilidade e seus aspectos envolvidos é um dos grandes desafios a serem superados no contexto do Sistema Único de Saúde – SUS (Pessoa; Almeida; Carneiro, 2018).

Nas últimas décadas, por meio principalmente dos movimentos sociais, os problemas presenciados nos territórios rurais ganharam maior visibilidade, culminando em 2014 com a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta e das Águas – PNSIPCF (Brasil, 2014). A PNSIPCF visa alinhar ações e serviços de saúde que atendam às PCFA ao reconhecer suas especificidades com o intuito de reduzir riscos e agravos acarretados pelos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas, com melhora nos indicadores de saúde e na qualidade de vida desta população (Carneiro *et al.*, 2014; Pessoa, 2015; Soares *et al.*, 2017).

Apesar dos reconhecidos atributos da APS de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação da atenção, atenção centrada na família, orientação comunitária e competência cultural, ainda existem barreiras a serem superadas no contexto brasileiro para sua implementação incluindo os territórios rurais. A saúde rural não pode ser desvinculada do funcionamento dos sistemas de saúde, principalmente em países em desenvolvimento,

s usuários (Starfield, 2002).

acesso aos serviços de saúde é uma das bases para a efetividade do primeiro principalmente associado às barreiras geográficas, e ao princípio da equidade, que busca priorizar as áreas de maior dificuldade de acesso, vulnerabilidade e com maiores problemas de saúde (Lima *et al.*, 2018).

A qualificação do acesso é um dos maiores desafios a serem superados na assistência à saúde das áreas rurais. A forma como os serviços de saúde estão organizados também se configura como determinante social da saúde e pode contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde das famílias rurais (Brasil, 2014; Macinko; Mendonça, 2018; Pessoa; Almeida; Carneiro, 2018).

A ampliação da cobertura de APS no Ceará tem sido um grande desafio para a gestão pública em saúde, apesar de apresentar um acréscimo importante das coberturas desde o ano de 2007. Observa-se que, em julho de 2007, a cobertura da APS era de 64,64% e, em maio de 2023, aumentou para 94,58% (Ceará, 2013).

A análise dos dados de saúde nos territórios rurais tem sido comprovadamente pior quando comparados aos espaços urbanos. Os indivíduos que moram nestas áreas rurais apresentam piores indicadores de autoavaliação de saúde como regular/ruim/muito ruim, de acesso à informação – por não saber ler e escrever –, de ocorrência da primeira gravidez antes de 20 anos, de pessoas com deficiência e usuários de tabaco, de não acesso aos serviços de saúde bucal e à mamografias, em mulheres com idade recomendada (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023).

Este estudo objetiva analisar a atuação das equipes de ESF do campo, da floresta e das águas em municípios do Estado do Ceará, região nordeste do Brasil.

## METODOLOGIA

Trata-se de estudo transversal exploratório e descritivo, com amostra intencional.

A pesquisa quantitativa é capaz de identificar a natureza das realidades, seu sistema de relações e sua estrutura dinâmica (Espéron, 2017). O caráter exploratório da pesquisa tem a intenção de proporcionar uma visão geral, aproximativa, acerca de determinado fato, e descritiva, pois focaliza características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (Gil, 2008). Os estudos transversais envolvem a coleta de dados em um ponto do tempo, não existindo seguimento de nenhum indivíduo (Zangirolami-Raimundo; Echeimberg; Leone, 2018). E a amostra intencional seleciona um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população (Marconi; Lakatos, 1996).

Esta pesquisa foi realizada no Estado do Ceará, com equipes da ESF, em cenários rurais dos municípios de Crato, Itapipoca, Quiterianópolis e Trairi, com profissionais de equipes da ESF e usuários dos serviços de saúde. O estudo foi realizado de abril a novembro de 2022.

Os quatro municípios estudados apresentam 100% de cobertura da APS. Quanto à população rural, o município de Crato tem aproximadamente 17% de população rural, Itapipoca apresenta 31%, Quiterianópolis 68% e Trairi 56% (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023).

anto Quiterianópolis e Trairi são classificados como rurais adjacentes (Souza; tti, 2020). Itapipoca e Trairi situam-se na microrregião de Itapipoca, Quiterianópolis à microrregião do Sertão de Crateús e Crato à microrregião do Cariri, integrante da Região Metropolitana do Cariri. Crato fica aproximadamente a 500km da capital do Estado do Ceará, Fortaleza. Itapipoca está a 117 km de distância de Fortaleza,

quantitativo constituído pela ficha de caracterização dos participantes e um questionário. A ficha de caracterização dos participantes foi aplicada com o objetivo de traçar um perfil sociodemográfico dos participantes relacionados à idade, estado civil, escolaridade, formação profissional e profissão atual. O questionário abordava variáveis relacionadas com a abordagem centrada no território; o acesso e acolhimento; a integralidade; a longitudinalidade e a coordenação do cuidado.

Ambos instrumentos foram distribuídos de forma impressa e lidos previamente pelo pesquisador para a explicação de dúvidas. O pesquisador realizava a leitura coletiva de cada variável e o participante respondia anonimamente no formulário (sim; não; não sabe). A seguir, os dados foram digitados em arquivo do *Microsoft Excel* para organização no formato de tabelas, onde foram realizadas análises estatísticas de implementação dos atributos da APS relacionadas ao cuidado em saúde, na visão dos profissionais de saúde e usuários. Para melhor visualização das informações contidas nas tabelas, o valor total foi calculado por regra de três simples, considerando as subvariáveis de cada variável.

O estudo foi desenvolvido respeitando os aspectos da ética em pesquisa presentes nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, Parecer nº 4.317.371.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 68 indivíduos, profissionais das equipes de ESF e usuários que participaram do estudo, todos preencheram a ficha de caracterização e 64 o questionário.

Os participantes foram predominantemente mulheres (61,8%, n=42), de 31 a 50 anos (47%, n=32).

A situação conjugal “casados” teve maior prevalência (42,6%, n=29). Em relação à escolaridade, a maior parte informou possuir o ensino médio completo (39,7%, n=27). Como principal atividade laboral, 30,9% dos participantes relataram trabalhar com a agricultura familiar (n=21). Sobre a formação profissional, a maioria dos participantes declararam não possuir formação (52,9%, n=36) e, a seguir, os profissionais da área da saúde, sendo seis com nível superior completo e seis com nível técnico de formação.

que a APS tem potencial para resolver cerca de 85% dos problemas de saúde

o os 30 anos de APS implantada no Brasil, espera-se que os processos de trabalho das equipes estejam implementados e consolidados nos diferentes territórios, devendo ofertar 100% das ações e serviços de saúde. Nos territórios rurais, entretanto, entende-se que haja desafios maiores, devido às dificuldades de acesso e de fixar força de trabalho (Mendes, 2011).

Medir a qualidade na APS é um desafio, dada a múltipla dimensão do conceito de desempenho, da influência de determinantes na demanda e nos resultados, assim como da complexidade dos serviços ofertados, principalmente quando sofre influência do perfil da população atendida, como é o caso dos territórios das PCFA que apresenta suas características locais.

Os resultados estão apresentados em cinco blocos: a) Abordagem centrada no território; b) Acesso e acolhimento; c) Integralidade da atenção às populações do campo, da floresta e das águas; d) Longitudinalidade; e) Coordenação do cuidado.

#### *Bloco A: Abordagem centrada no território*

Abriga parâmetros relativos a métodos, técnicas e instrumento(s) para identificar de forma participativa as necessidades sociais em saúde dos territórios, diagnóstico local da população adscrita, mapa de sua área de abrangência (que se visualize postos formais e informais de trabalho, riscos ocupacionais e ambientais), equipamentos e serviços existentes no território e informações sobre determinantes sociais da saúde.

Analisando os resultados relativos à abordagem centrada no território, observa-se que os cuidados em saúde não estão baseados na realidade dos territórios, visto que não são desenvolvidos métodos, técnicas e instrumentos para identificar de forma participativa as necessidades sociais em saúde dos territórios. A equipe não possui o mapa de sua área de abrangência, onde se identificam os principais postos formais e informais de trabalho (agronegócio, fábricas, indústrias, áreas comerciais, serviços, etc.), bem como os riscos ocupacionais e ambientais (desastres, contaminação da água, do solo, do ar) decorrentes das atividades produtivas presentes no território, como se observa na Tabela 1.

A não realização dessas práticas vem ao encontro do pensamento de Souza, Gomes e Zanetti (2020), que diz que o território, a saúde das populações e as políticas de saúde pública estão interligados e favorecem a redemocratização da sociedade, representando o potencial de aprimoramento das análises e da política da ESF. Portanto, a prática de territorializar também deve ser concebida sob a lógica organizacional dos serviços de saúde. Com esta prática, os executores das políticas de saúde conseguem aproximar-se dos territórios e estabelecer vínculos com as populações e a realidade de seu lugar de vida.

Observa-se a necessidade em fortalecer a atenção da APS no território, pois percebe-se que a ESF não está inteirada das necessidades de saúde da comunidade, não conhece o território, suas potencialidades e problemas, pois, muitas vezes, não vai até a comunidade. Mas realiza os atendimentos assistenciais na Unidade de Saúde para aqueles que a buscam com alguma queixa, não voltando suas ações para a realidade dos territórios.

Macinko e Mendonça, (2018) expõem a necessidade de avaliação das disparidades territoriais na saúde, especialmente a elaboração de territorialização eficaz, que leve em

hados às necessidades da população. Tais necessidades advêm da percepção de ários, enquanto o modo de organizar os serviços depende do reconhecimento ades de cada comunidade.

A ESF, para atingir a eficácia das suas propostas, deve valorizar o lugar geográfico em que atua, defendendo a participação da comunidade no planejamento territorial em saúde, possibilitando uma melhor intervenção local, uma vez que os usuários são os agentes políticos que melhor podem auxiliar na consolidação da ESF em seus territórios.

**Tabela 1** – Análise da atuação de equipes da ESF em territórios das populações do campo, da floresta e das águas, quanto à abordagem centrada no território, no Estado do Ceará, Brasil (n=64).

| ABORDAGEM CENTRADA NO TERRITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM<br>n (%)     | NÃO<br>n (%)     | NR<br>n (%)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. Desenvolve métodos, técnicas e instrumentos para identificar de forma participativa as necessidades sociais em saúde dos territórios.                                                                                                                                                                                                                               | 25 (39,1)        | 38 (59,3)        | 1 (1,6)        |
| 2. A equipe possui diagnóstico local da população adscrita, com informações de número de pessoas, por sexo e faixa etária, e classificação de risco das famílias.                                                                                                                                                                                                      | 54 (84,4)        | 9 (14,0)         | 1 (1,6)        |
| 3. A equipe possui mapa de sua área de abrangência e nele estão identificados os principais postos formais e informais de trabalho (agronegócio, fábricas, indústrias, áreas comerciais, serviços etc.), bem como os riscos ocupacionais e ambientais (desastres, contaminação da água, do solo, do ar) decorrentes das atividades produtivas presentes no território. | 24 (37,5)        | 38 (59,4)        | 2 (3,1)        |
| 4. Os recursos da comunidade como equipamentos (creches, escolas, igrejas, praças, hortas comunitárias etc.) e serviços sociais existentes (grupos culturais ou de esporte) são identificados pela equipe.                                                                                                                                                             | 44 (68,7)        | 19 (29,7)        | 1 (1,6)        |
| 5. Os determinantes sociais da saúde da população adscrita são identificados a partir de dados como o número de domicílios, densidade familiar, condições de moradia, abastecimento de água, destino de fezes e urina, e destino do lixo, renda familiar e escolaridade.                                                                                               | 45 (70,3)        | 14 (21,9)        | 5 (7,8)        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>38 (59,4)</b> | <b>24 (37,5)</b> | <b>2 (3,1)</b> |

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2022.

Legenda: n - número absoluto do total de respondentes; (%) - Frequência simples; NR - Não respondeu.

### *Bloco B: Acesso e acolhimento*

Os parâmetros se referem a uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros “reais” entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas (Brasil, 2013).

Percebe-se que esse atributo de muita relevância para a APS não está sendo executado pelas equipes como se espera, pois este se refere a não se restringir à entrada no serviço de saúde, mas a existência de serviços de acordo com a necessidade da população. Refere-se também a aspectos organizacionais, geográficos, econômicos e socioculturais, sendo ligado à questão da resolutividade.

O Caderno da Atenção Básica (Brasil, 2013) sobre acolhimento, orienta que, a despeito da existência de formas cientificamente fundadas de definição objetiva das necessidades de

aus variados, o que é necessidade de saúde para ele, podendo apresentá-la da ao serviço de saúde.

que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, problematizada e reconhecida como legítima. O exercício de acolher amplia o acesso por contemplar diferentes agendas, seja programada ou espontânea, abordando-se cada uma dessas situações segundo as especificidades de suas dinâmicas e tempos. O acolhimento adequado fortalece vínculos, resulta de um processo de reconhecimento das necessidades individuais e familiares, sedimentando a responsabilização pelo cuidado de forma compartilhada, constituindo-se a representação de uma espiral que se complementa e evolui de forma ascendente e contínua (Tabela 2).

**Tabela 2** – Análise da atuação de equipes da ESF em territórios das populações do campo, da floresta e das águas, quanto ao acesso e acolhimento no Estado do Ceará, Brasil (n=64).

| ACESSO E ACOLHIMENTO                                                                                                                                                                                                                                        | SIM<br>n (%)     | NÃO<br>n (%)     | NR<br>n (%)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. As necessidades sociais em saúde da população são o referencial para a definição das ações e serviços ofertados pela equipe, da organização dessa oferta e do funcionamento da Unidade Básica de Saúde (horário de atendimento e formas de agendamento). | 36 (56,2)        | 27 (42,2)        | 1 (1,6)        |
| 2. Realiza o acolhimento, com atendimento humanizado, com avaliação de risco e de vulnerabilidade, identificação das necessidades de intervenção de cuidado, responsabilização pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.    | 31 (48,4)        | 32 (50,0)        | 1 (1,6)        |
| 3. Realiza o acolhimento à demanda espontânea, realizando a classificação e a estratificação de risco, priorizando o atendimento aos casos de urgência ou emergência.                                                                                       | 46 (71,9)        | 17 (26,5)        | 1 (1,6)        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 (59,4)</b> | <b>25 (39,0)</b> | <b>1 (1,6)</b> |

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2022.

Legenda: n - número absoluto do total de respondentes; (%) - Frequência simples; NR - Não respondeu.

### *Bloco C: Integralidade da atenção às populações do campo, da floresta e das águas*

É materializada a partir de um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, bem como o cuidado sistêmico do indivíduo

Os resultados desse estudo mostram que a integralidade, que prevê a atenção integral na perspectiva a APS e que deve oferecer serviços para que o usuário possa ter acesso a medidas de prevenção, promoção, cura e reabilitação, não está sendo considerada como deveria na prestação de serviços desse território (Tabela 3).

O alcance desse atributo está relacionado além da organização dos processos de trabalho da equipe e a responsabilização pelo cuidado, à organização da oferta de serviços e ações de saúde em outros níveis de atenção que extrapolam a APS, a aspectos de organização do sistema de regulação municipal, a serviços de apoio diagnóstico/terapêutico e a um adequado



**lise da atuação de equipes da ESF em territórios das populações do campo, da águas, quanto à integralidade no Estado do Ceará, Brasil (n=64).**

| <b>INTEGRALIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SIM<br/>n (%)</b> | <b>NÃO<br/>n (%)</b> | <b>NR<br/>n (%)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. A equipe provê atendimento adequado às situações de maior complexidade e dá suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros pontos da RAS.                                                                                                                                                                                                                   | 48 (75,0)            | 16 (25,0)            | -- (--)             |
| 2. A equipe viabiliza transporte sanitário para o usuário que necessita ser transferido para outro ponto da RAS.                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 (46,9)            | 31 (48,4)            | 3 (4,7)             |
| 3. A equipe possibilita o agendamento de exames complementares de diagnóstico, de outras ações e serviços em outros níveis de atenção.                                                                                                                                                                                                                                | 55 (85,9)            | 7 (11,0)             | 2 (3,1)             |
| 4. A equipe busca a integralidade do cuidado, identificando as especificidades das PCFA e realizando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, realização de ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde.                                                                                                       | 37 (57,8)            | 27 (42,2)            | -- (--)             |
| 5. A equipe realiza ações de promoção ou assistência em saúde do trabalhador e da trabalhadora das PCFA.                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 (32,8)            | 41 (64,1)            | 2 (3,1)             |
| 6. A equipe realiza ações intrasetoriais de saúde, em especial com a vigilância, para reduzir os acidentes e agravos relacionados aos processos de trabalho das PCFA.                                                                                                                                                                                                 | 17 (26,6)            | 44 (68,7)            | 3 (4,7)             |
| 7. A equipe incorpora diversas racionalidades em saúde, respeitando e recomendando os saberes e práticas tradicionais de cuidado das PCFA e as Práticas Integrativas e Complementares.                                                                                                                                                                                | 34 (53,1)            | 30 (46,9)            | -- (--)             |
| 8. A equipe contribui para o fortalecimento da autonomia das pessoas no cuidado à saúde, estabelecendo articulação orgânica com o conjunto da Rede de Atenção à Saúde.                                                                                                                                                                                                | 36 (56,3)            | 26 (40,6)            | 1. 2 (3,1)          |
| 9. A equipe desenvolve ações intersetoriais em interlocução com escolas, equipamentos do Sistema Único de Assistência Social, associações de moradores, cooperativas, sindicatos, equipamentos de segurança, entre outros, que tenham relevância na comunidade, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral. | 30 (46,9)            | 33 (51,6)            | 1 (1,6)             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 (53,1)</b>     | <b>27 (42,2)</b>     | <b>3 (4,7)</b>      |

**Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2022.**

Legenda: n - número absoluto do total de respondentes; (%) - Frequência simples; NR - Não respondeu.

#### *Bloco D: Longitudinalidade*

Trata-se do acompanhamento do paciente ao longo do tempo pela equipe de APS para os múltiplos episódios de doença e cuidados preventivos (Brasil, 2013).

Os resultados demonstram que as crianças, gestantes, diabéticos, hipertensos e idosos são identificados, estratificados por grau de risco e acompanhados de acordo com essa estratificação. Assim como os usuários com hanseníase e os casos de dengue, zika e chikungunya são diagnosticados, tratados e acompanhados pela equipe, conforme protocolo clínico (Tabela 4).

cida pela equipe de saúde tendo em conta o caráter mútuo, humanizado e relação de confiança recíproca entre a equipe de saúde e a população. Nos ados há uma relação de confiança e reconhecimento dos esforços empreendidos pelas equipes no sentido de garantir a continuidade do cuidado, nas formas mais diversas das necessidades apresentadas.

**Tabela 4 – Análise da atuação de equipes da ESF em territórios das populações do campo, da floresta e das águas, quanto à longitudinalidade no Estado do Ceará, Brasil (n=64).**

| LONGITUDINALIDADE                                                                                                                                                                 | SIM<br>n (%)     | NÃO<br>n (%)     | NR<br>n (%)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. As crianças da área de responsabilidade da equipe com até um ano de vida são identificadas, estratificadas por grau de risco e acompanhadas de acordo com essa estratificação. | 59 (92,2)        | 3 (4,7)          | 2 (3,1)        |
| 2. As gestantes da área são captadas, estratificadas por grau de risco e acompanhadas durante o pré-natal e puerpério.                                                            | 62 (96,9)        | 2 (3,1)          | -- (--)        |
| 3. As mulheres na faixa etária preconizada para a realização dos exames de citologia de colo de útero e mamografia estão identificadas e são acompanhadas.                        | 60 (93,8)        | 2 (3,1)          | 2 (3,1)        |
| 4. Os diabéticos da área são identificados, estratificados por grau de risco e acompanhados de acordo com essa estratificação.                                                    | 52 (81,3)        | 10 (15,6)        | 2 (3,1)        |
| 5. Os hipertensos da área são identificados, estratificados por grau de risco e acompanhados de acordo com essa estratificação.                                                   | 57 (89,1)        | 7 (10,9)         | -- (--)        |
| 6. Os idosos da área são identificados, estratificados por grau de risco e acompanhados de acordo com essa estratificação.                                                        | 45 (70,3)        | 16 (25,0)        | 3 (4,7)        |
| 7. Os usuários com tuberculose, residentes no território, são diagnosticados e tratados pela equipe.                                                                              | 35 (54,7)        | 20 (31,2)        | 9 (14,1)       |
| 8. Os usuários com hanseníase, residentes no território, são diagnosticados e tratados pela equipe.                                                                               | 45 (70,3)        | 15 (23,4)        | 4 (6,2)        |
| 9. Os casos de dengue, zika e chikungunya de usuários residentes no território são atendidos e acompanhados pela equipe, conforme protocolo clínico.                              | 50 (78,1)        | 12 (18,8)        | 2 (3,1)        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      | <b>52 (81,3)</b> | <b>52 (81,3)</b> | <b>2 (3,1)</b> |

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2022.

Legenda: n - número absoluto do total de respondentes; (%) - Frequência simples; NR - Não respondeu.

### *Bloco E: Coordenação do cuidado*

Estabelece conexões de modo a alcançar o objetivo maior de prover/atender às necessidades e preferências dos usuários na oferta de cuidados em saúde, com elevado valor, qualidade e continuidade (Almeida *et al.*, 2018).

Os resultados apontam que as equipes não mantêm como deveriam a coordenação do cuidado quando a população adscrita necessita de atenção em outros pontos do sistema de saúde, não realiza de forma adequada o monitoramento das internações por condições sensíveis à APS ocorridas em seu território, não realiza todas as notificações compulsórias de agravos e doenças, inclusive aqueles relacionados à saúde do trabalhador e da trabalhadora,

se que a coordenação do cuidado precisa ter maior importância pelas equipes, buto busca a integração da rede de serviço e a continuidade da atenção por mação, executando registro dos procedimentos realizados em prontuários e coordenando a interface dos serviços.

A valorização das informações epidemiológicas, seja no aspecto de registro de agravos pelas notificações, seja no cuidado com o registro das informações acerca de formas de adoecimento da população adscrita, bem como o monitoramento dos motivos de internação, são elementos fundamentais que demonstram a adequada coordenação do cuidado com respostas positivas ao serem utilizados e valorizados pela equipe.

**Tabela 5 – Análise da atuação de equipes da ESF em territórios das populações do campo, da floresta e das águas, quanto à coordenação do cuidado no Estado do Ceará, Brasil (n=64).**

| COORDENAÇÃO DO CUIDADO                                                                                                                                                 | SIM<br>n (%) | NÃO<br>n (%) | NR<br>n (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. A equipe mantém a coordenação do cuidado mesmo quando a população adscrita necessita de atenção em outros pontos do sistema de saúde.                               | 36 (56,3)    | 26 (40,6)    | 2 (3,1)     |
| 2. A equipe realiza o monitoramento das internações por condições sensíveis à APS ocorridas em seu território.                                                         | 29 (45,3)    | 32 (50,0)    | 3 (4,7)     |
| 3. São realizadas notificações compulsórias de agravos e doenças, inclusive aqueles relacionados à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, para a Vigilância em Saúde. | 38 (59,4)    | 20 (31,2)    | 6 (9,4)     |
| 4. A equipe alimenta os sistemas de informação sob sua responsabilidade.                                                                                               | 43 (67,2)    | 15 (23,4)    | 6 (9,4)     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                           | 37 (57,8)    | 23 (35,9)    | 4 (6,3)     |

**Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2022.**

Legenda: n - número absoluto do total de respondentes; (%) - Frequência simples; NR - Não respondeu.

Para organizar o SUS de forma integrada, possibilitando a atenção de melhor qualidade com menor custo, é preciso estabelecer um ponto de primeiro contato com o sistema de saúde, capaz de articular cuidados preventivos e curativos e integrar a rede de cuidados

se dá pela APS, é o acolhimento, o qual ocorre pelo ato de escutar as pessoas para satisfação das suas necessidades em saúde. Promover a recepção do usuário, a avaliação de riscos, de vulnerabilidade e a realização das intervenções necessárias são ações corriqueiras da ESF (Vicari; Lago; Bulgarelli, 2022).

Menos da metade dos participantes (39,6%) das comunidades estudadas negou haver o acesso e acolhimento ideal, indicando que apesar dos avanços na prestação do cuidado na APS, melhorias são necessárias. Melhor organização do agendamento de consultas, além de

viços de prontidão em situações não urgentes (Mendes, 2011).

inko et al. (2018), no Brasil, seja na percepção dos profissionais, seja na dos principais barreiras do acesso geográfico incluem a localização da unidade, as características locais, o transporte e a delimitação inadequada do território de abrangência, além das limitações físicas e financeiras para o deslocamento aos serviços especializados.

Quanto ao cuidado integral, este estudo evidenciou poucas ações intrasetoriais de saúde. Para os trabalhadores da saúde e usuários participantes das comunidades estudadas, a integralidade está sendo exercida de forma positiva por pouco mais da metade dos participantes (53,4%).

Para Starfield (2002), a integralidade exige que a atenção primária reconheça, adequadamente, a variedade completa de necessidades relacionadas à saúde do paciente e disponibilize recursos para abordá-las, assim a integralidade é importante pois assegura que os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde, disponibilizando uma variedade de serviços que possa atender as necessidades comuns à população atendida.

Corroborando com Macinko et al. (2018), a prática da integralidade é desafiadora, busca uma postura holística, humanizadora e participativa que exige comprometimento de todos os atores envolvidos, sejam usuários, profissionais e governos. Depende de ações coletivas, deve ser articulada em redes de atenção para agir sobre os determinantes sociais que desgastam a saúde. Deve ser operacionalizada de forma multidisciplinar e intersetorial, considerando a cultura, o estilo de vida, a crença e a posição social dos assistidos, fortalecendo os vínculos, a promoção de saúde e a prevenção de doenças.

Mais de 80% dos participantes do estudo consideraram que a longitudinalidade está sendo praticada. Esse atributo pressupõe uma fonte continuada de atenção ao longo do tempo, com a presença de vínculo entre usuários e profissionais de saúde. Possibilita conhecer o usuário, em seu contexto familiar e social, seus comportamentos, hábitos e problemas de saúde, permitindo o planejamento de cuidados e intervenções adequadas (Vicari; Lago; Bulgarelli, 2022).

Apesar do baixo percentual de participantes que responderam negativamente ao parâmetro da longitudinalidade (15,6%), os fatores que os motivaram coincidem com os resultados encontrados por Kessler et al. (2019), ao mostrarem fragilidades em relação à comunicação entre profissionais-usuários, no reconhecimento do indivíduo em sua integralidade, considerando o seu contexto familiar e social. Além disso, devem se considerar questões que ocasionam a alta rotatividade dos profissionais de saúde, como a precarização do trabalho, uma vez que a descontinuidade do trabalho dos profissionais de saúde interfere

defendendo seus pacientes e lhes garantindo alcançar outros pontos de atenção de maneira

stituição das RAS, mas esta é uma relação de mão dupla. Da mesma forma que S sem APS robusta, capaz de coordenar o cuidado, a APS não consegue exercer um sólido arranjo regional, além da articulação entre os três entes federados. Uma coordenação do cuidado fraca impede a garantia da integralidade, do acesso e da oferta de serviços de saúde de qualidade (Gomide et al., 2018).

O investimento em instrumentos de integração entre os serviços, portanto, é fundamental para o gerenciamento do cuidado pela APS. A integração do cuidado depende dos processos de coordenação, da eficácia da comunicação, de profissionais cientes em partilhar informações. Requer o fortalecimento do trabalho em equipe, promovendo a transformação da prática cotidiana, de uma perspectiva fragmentada para uma visão integrada (Kessler et al., 2019).

## CONCLUSÃO

Este estudo retrata um recorte importante da atuação das equipes da ESF do campo, da floresta e das águas em municípios do Ceará, estado que foi o berço da implantação do modelo de saúde da família no Brasil e, em especial, foca na PNSIPCFA no cenário cearense, o que trouxe desafios relacionados às práticas de cuidados primários a essa população.

A avaliação da presença e extensão dos atributos essenciais de APS nos territórios estudados apresentou fragilidades nos serviços em geral, onde apenas o atributo da longitudinalidade apresentou resultados positivos. A partir da análise dos processos de trabalho das equipes de saúde descritas neste estudo, percebeu-se que as trocas de vivências entre profissionais da saúde-usuários e a união dos conhecimentos científicos e populares são fatores necessários e urgentes no processo de produção da saúde.

Uma conclusão importante deste estudo é que muitos dos parâmetros comuns à ESF – como práticas de cuidado, oferta de ações e serviços de saúde –, que deveriam ser praticados no cotidiano do cuidado, não estão sendo realizados. Portanto, além de compreender as ações que estão sendo desenvolvidas por trabalhadores e por comunidades, observou-se a necessidade de reforçar a prática dos atributos definidos pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Quanto às práticas da ESF nessas localidades, a abordagem centrada no território para os participantes dessa pesquisa, faz-se necessária uma maior aproximação da ESF com o território, no sentido de promover uma saúde mais voltada para suas carências originadas inclusive pelo modo de vida e trabalho locais.

Fator importante observado pelas equipes de saúde e usuários é a necessidade de voltarem suas práticas cotidianas para as necessidades dos usuários, criando ações que vão além da assistência na Unidade de Saúde. Precisa-se alertar os gestores sobre a urgência do desapego das metas de produção dos profissionais, metas essas que precisam ser revistas pelo Ministério da Saúde quando instituiu o financiamento da APS pelo Previn Brasil, forma de pagamento por desempenho para o alcance de indicadores restritivos ao cuidado integral dos usuários e à promoção de saúde nos territórios, com destaque para as comunidades rurais (Ceará, 2023).

Considerando a questão do acesso e a distância da Unidade de Saúde, observam-se relatos da necessidade de humanização no cuidado, bem como de uma maior aproximação entre

rições de remédios. A aprendizagem mútua deve ser um exercício contínuo. Adequação do saber aproxima os diferentes e evidencia a necessidade de uma cons-  
a saúde.

A humanização do cuidado, entendida como um maior acolhimento e acesso aos serviços da ESF e à busca pela equidade, visa um alcance universal, de modo que as populações mais vulneráveis, como as PCFA, sejam escutadas em suas necessidades e em seus modos de cuidar, os quais baseiam-se nas peculiaridades de seus territórios. Tais mudanças melhoram a qualidade de vida dos usuários e dos trabalhadores, qualificando as ações das equipes de saúde para além da assistência e facilitando a autonomia no cuidado por parte da população.

## Referências

ALMEIDA, M. M. *et al.* A formação em saúde em contextos rurais. In: SAVASSI, L. C. M. *et al.* **Saúde no caminho da roça**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. p. 67-95.

ARRUDA, C. A. M. **Formação de agentes comunitários de saúde e enfermeiros no programa Cresça com seu Filho: potencialidades e desafios**. 2019. 226 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Acolhimento à demanda espontânea**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.311, de 23 de outubro de 2014**. Altera a Portaria nº 2.866/GM/MS, de 2 de dezembro de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF). Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

GERHARDT, T. E.; LOPES, M. J. M. Pensar o rural e a saúde: elementos teóricos e metodológicos. In: GERHARDT, T. E.; LOPES, M. J. M. **O rural e a saúde**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

LIMA, M. C. *et al.* O fazer rural. In: SAVASSI, L. C. *et al.* **Saúde no caminho da roça**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. p. 31-65.

; LAKATOS, E. M. **Research techniques, planning and execution of research, sampling and research ration, analysis and interpretation of data**. 3. ed. São Paulo Atlas, 1996.  
**s redes de atenção à saúde**. Brasília: Organização Panamericana da Saúde, 2011.

PESSOA, V. M. **Ecologia de saberes na tessitura de um pensamento em saúde no sertão**: do conhecimento regulação às práticas emancipatórias na estratégia saúde da família. [tese] Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

SOARES, R. A. S. *et al.* A invisibilidade da população do campo, da floresta e das águas no Brasil: desafio para os sistemas de informações em saúde. In: CARNEIRO, F. F.; PESSOA, V. M.; TEIXEIRA, A. C. A. (org.) **Campo, floresta e águas: práticas e saberes em saúde**. Brasília: Universidade de Brasília, 2017. Cap. 5, p. 106-124.

STARFIELD, B. **Atenção Primária**: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologias. Brasília: Unesco, MS, 2002.

## Fonte de financiamento

Estudo financiado pelo Edital da Fiocruz da Rede PMS-APS 2020-2023.

## Contribuição dos autores

Andressa Oliveira Braz Dias - concepção e planejamento do estudo, elaboração do texto, coleta e análise dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Carlos André Moura Arruda - concepção e planejamento do estudo, elaboração do texto, coleta e análise dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Alissan Karine Lima Martins - revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Vanira Matos Pessoa - concepção e planejamento do estudo, elaboração do texto, coleta e análise dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

## ade editorial

Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, Rafael Arenhaldt, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil

Recebido em: 29/01/2025

Aceito em: 02/04/2025

Publicado em: 07/04/2025